

7.10 Aspirationsprophylaxe

Aspiration

DEFINITION

Aspiration (lat. aspirare = anhauchen): Fremdkörper, Nahrung und Flüssigkeit gelangen über die Trachea in die Lunge.

Penetration (lat. penetrare = eindringen): Fremdkörper, Nahrung und Flüssigkeit dringen in den Kehlkopf ein, verbleiben aber oberhalb der Stimmbänder.

Alle Patienten mit einer Schluckstörung (→ 7.11.2) sind aspirationsgefährdet. Auch beim Erbrechen und durch Regurgitation (*Zurückströmen von Magensaft in die Mundhöhle*), bei fehlendem Verschluss des Mageneingangs oder Überfüllung des Magens besteht Aspirationsgefahr.

Fremdkörper, die in die Atemwege gelangt sind, lösen den **Hustenreflex** aus, sofern dieser erhalten ist. Gelingt das Aushusten nicht, können größere Fremdkörper die Luftröhre verlegen: Der Patient bekommt keine Luft und droht zu ersticken.

Kleinere Teile, die bis in die Lunge gelangen, schädigen das Gewebe. Es reagiert mit

einer Entzündung auf den Reiz. Die Folge ist eine **Pneumonie** (*Lungenentzündung*, → 23.4.4), in diesem Fall eine **Aspirationspneumonie**. Gerade bei alten und kranken Menschen kann diese Erkrankung einen schweren Verlauf nehmen, oft mit tödlichem Ausgang.

Besonders gefährlich ist es, wenn Erbrochenes aspiriert wird, da die Nahrung dann schon mit den Verdauungsenzymen und der Salzsäure des Magens durchsetzt ist, was die Bronchialschleimhaut sehr stark angreift.

-  **VORSICHT!** Die **Aspirationsgefahr** wird oft unterschätzt. Aspirationspneumonie und Erstickten können lebensbedrohliche Folgen einer verfrühten Nahrungsaufnahme sein. Gefährdet sind insbesondere:
- Patienten, die länger nichts gegessen haben oder intubiert waren
 - Patienten mit neurologischen Erkrankungen, z. B. Schlaganfall (→ 37.6), Myasthenia gravis (→ 37.16.1)
 - Desorientierte, alte Patienten
 - Patienten, die oft erbrechen
 - Frühgeborene.

Maßnahmen nach Aspiration

Kräftiges Klopfen auf den Rücken zwischen die Schulterblätter unterstützt den Patienten beim Aushusten. Ist dies nicht erfolgreich, soll er mit vorgebeugtem Oberkörper nochmals kräftig husten und so versuchen, den „verschluckten“ Bissen herauszuwürgen. Gelingt dies nicht, wird das Aspirierte endotracheal abgesaugt (→ 3.5.4). In jedem Fall ist der Arzt über die Aspiration zu informieren.

Als *letzte* Möglichkeit, die aber für den Patienten erhebliche Schäden nach sich ziehen kann (Zwerchfellruptur, Magenwandverletzungen), wird der **Heimlich-Handgriff** angewendet (→ 14.6.9).

Maßnahmen zur Aspirationsprophylaxe

i DEFINITION

Aspirationsprophylaxe: Maßnahmen, die ein Eindringen von Nahrung oder anderen Fremdkörpern in die Luftröhre (*Trachea*) verhindern.

Die **Aspirationsprophylaxe** umfasst:

- Positionierung des Patienten mit erhöhtem Oberkörper zum Essen und Trinken, außerdem nach dem Essen für mindestens 20–30 Min. (gleichzeitige Refluxprophylaxe, → 24.4.1)
- Anwesenheit der Pflegenden, während der Patient isst und trinkt; ggf. Anleitung des Patienten
- Nahrungsaufnahme in Ruhe ermöglichen, Patienten nicht drängen
- Geeignete Speisen und Getränke individuell für den Patienten auswählen, trockene Speisen vermeiden
- Bereitstellung eines Absauggeräts (→ 3.5.4), um *vor* dem Essen Sekret aus dem Mund entfernen zu können und *nach* dem Essen evtl. Speisereste abzusaugen, was ein nachträgliches Aspirieren verhindert
- Mundhygiene vor dem Essen, um Mundschleimhaut anzufeuchten sowie nach dem Essen, um Essensreste zu entfernen
- Säuglinge in aufrechter Haltung aufstoßen lassen, um eine Aspiration von Nahrung zu vermeiden.

SPICKZETTEL

Aspirationsprophylaxe

Wesentliche Ursachen für eine Aspiration:

- Schluckstörung
- Erbrechen, Regurgitation
- Fehlender Hustenreflex.

Maßnahmen zur Aspirationsprophylaxe:

- Nahrung und Getränke immer in sitzender Position einnehmen/verabreichen
- Patienten beim Essen und Trinken nicht allein lassen
- Dem Patienten ausreichend Zeit lassen
- Mundhygiene vor und nach der Mahlzeit anbieten/durchführen
- Absauggerät bereithalten.